随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

主公不三不四

2.正常主动脉瓣口面积 3-4cm²，**主动脉瓣口面积≤1cm² 时才出现临床症状**：

心绞痛 **（最早、最常见）**	**冠脉灌注减少（主动脉根部舒张压↓、左室舒张压↑）** **毛细血管密度↓、心肌耗氧增加**
不同程度的**呼吸困难**	左室压力↑→左房压力↑→肺V回流障碍→肺瘀血、肺水肿
晕厥（15-30%） 出现晕厥者 50%在 3 年内死亡	多为运动后晕厥。若休息时发生晕厥主要与**室性快速型心律失常**、房颤、房室阻滞导致心排出量骤减有关

末期 ∧ 力

无论肥厚型心肌病的晕厥还是主狭的晕厥都跟室性快速型心律失常有关

二狭更多强调的是左心衰VS主狭更多强调的是心绞痛、晕厥

急性肺心病导致右心室急剧扩大，将室间隔推向左边，左心腔明显↓

可致心绞痛的疾病：冠心病、主狭、主闭、高血压、肥厚型心肌病、肺栓塞、X 综合征（冠脉微循环不良）等（供氧耗氧不平衡）

主动脉不仅往外周流血，还通过没有关全的主动脉瓣反流到左心室，导致主动脉里的舒张压显著↓，冠脉的灌注↓

（四）治疗（看年龄）

①儿童和青少年的非钙化先天性主狭：直视下主动脉瓣分离术

②成人：瓣膜**置换术**，若老龄①/重度②主狭/不耐受③外科手术者可行**经导管主动脉瓣置换术 TAVR**（介入）

同时满足

（五）主动脉瓣狭窄 VS 肥厚型梗阻性心肌病

共性：胸痛、呼吸困难、运动晕厥（与室性快速型心律失常有关）、A_2 减弱、S_4 奔马律、收缩期杂音呈喷射样、超声心动图为首选和金标准

心室肥厚



心室顺应性↓不能快速充盈→心房代偿收缩

区别：

室间隔听诊区

①肥厚型梗阻性心肌病：青年多见，**胸骨左缘 3-4 肋间收缩期杂音**、**不向颈部传导**，**用 β-R 拮抗剂、非二氢吡啶 CCB、蹲位卧位使杂音减弱**，超声心动图左室**不对称肥厚（室间隔/后壁＞1.3）**、收缩期二尖瓣前叶前移（**SAM**）致左室流出道梗阻

第一听诊区

②主动脉瓣狭窄：中老年多见（危险因素类似冠心病），**胸骨右缘 2 肋间收缩期杂音**、**可向颈部传导**，超声心动图主动脉瓣瓣叶增厚、回声增强/钙化、瓣叶收缩期开放幅度和速度减小、左室后壁和室间隔**对称**肥厚

四、主动脉瓣关闭不全（主动脉瓣反流）

（一）病因

①主动脉瓣本身病变：感染性心内膜炎、风湿病、先天性畸形、退行性钙化、黏液样变性致脱垂

②主动脉根部扩张：Marfan 综合征、梅毒、高血压、银屑病性关节炎、强直性脊柱炎、主动脉夹层（马冬梅高颜值-假）

（二）慢性主闭的临床表现 VS 肺动脉瓣关闭不全 听诊部位不同

1.杂音

主A瓣第二听诊区

①**胸骨左缘 3-4 肋间、舒张期、高调递减型杂音，常叹气样、向心尖传导。慢性轻度反流者杂音仅出现于舒张早期、柔和（坐位前倾、呼气末才能闻及），而中重度反流者杂音全舒张期、粗糙**

②**可致相对性二狭（心尖舒张期杂音/Austin-Flint 杂音）**

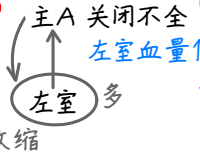
佛主闭关

③**可致相对性主狭（胸骨右缘 2 肋间收缩中期杂音）**



Graham-Steell杂音(功能性杂音):严重肺动脉高压致肺动脉扩张致相对性肺动脉瓣关闭不全(胸骨左缘2肋间舒张早期递减型,高调叹气或吹风样杂音)

杂音递增递减



左室血量↑→收缩期大量血液通过主A瓣

打工人挤地铁

杂音只在中期出现：

①二狭并发房颤：心尖舒张中期杂音 心房失去有效收缩

②严重二闭→相对性二狭：心尖舒张中期杂音

③严重主闭→相对性主狭：胸骨右缘 2 肋间收缩中期杂音 功能性杂音,只会在最明显的时期听到